Клинические рекомендации

Парезы и параличи гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J38.0** — Паралич голосовых складок и гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 07.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/305_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Осмотр врача-оториноларинголога 5

3.3 Общий анализ крови 6

3.4 Ларингоскопия 6

3.5 Лучевые методы исследования 6

3.6 Консультации специалистов 6

4. Лечение 7

4.1 Медикаментозное лечение 7

4.2 Логопедическая коррекция, физиотерапия и реабилитация 7

4.3 Хирургическое лечение у взрослых 7

4.4 Хирургическое лечение у детей 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Показания к госпитализации 9

5.2 Диспансерное наблюдение 9

5.3 Редкие синдромы с парезом гортани 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Парез гортани: нарушение подвижности мышц гортани из-за нарушения иннервации **до 6 месяцев**; паралич — **более 6 месяцев**. Чаще всего — после операций на щитовидной железе.
- Диагноз устанавливается по данным ларингоскопии: голосовая складка неподвижна или резко ограничена в подвижности. Для поиска причины — КТ шеи и грудной клетки, УЗИ гортани и шеи, эндокринолог и невролог.
- Одностороннее поражение: как можно раньше логопедическая коррекция голоса, у взрослых в ранние сроки — антихолинэстеразные препараты и витамины группы В; реконструктивная операция — **после 6 месяцев**. Двустороннее с декомпенсацией дыхания — трахеотомия или хордопексия.
- Срочная госпитализация — паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации; плановая — для операции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. парез гортани: временное, **до 6 месяцев**, отсутствие или ограничение подвижности мышц гортани вследствие нарушения иннервации;
2. паралич гортани: длительное, **более 6 месяцев**, отсутствие подвижности мышц гортани.

2.2 Этиология

Односторонний паралич: причины

1. операции на щитовидной и околощитовидных железах;
2. операции при атеросклерозе сонных артерий, раке лёгкого, врождённых пороках сердца;
3. новообразования со сдавлением возвратного нерва: рак щитовидной железы, лёгкого, пищевода, метастазы в лимфатические узлы средостения;
4. операции на шейном отделе позвоночника, травма, опухоли головного мозга, инсульт, демиелинизирующая нейропатия;
5. перенесённая ОРИ, туберкулёз лёгких;
6. причина не установлена (идиопатический паралич).

Частота причин одностороннего паралича

1. операции на щитовидной и околощитовидных железах: 72,4%;
2. операции при атеросклерозе сонных артерий, раке лёгкого, врождённых пороках сердца: 7,2%;
3. новообразования: 6,8%;
4. операции на шейном отделе позвоночника, травма, опухоли мозга, инсульт, демиелинизирующая нейропатия: 5,7%;
5. перенесённая ОРИ, туберкулёз лёгких: 4,5%;
6. идиопатический: 3,4%.

Двусторонний паралич: причины

1. хирургическая травма;
2. злокачественные новообразования;
3. эндотрахеальная интубация;
4. неврологические заболевания;
5. причина неизвестна.

Частота причин двустороннего паралича

1. хирургическая травма: 44%;
2. злокачественные новообразования: 17%;
3. эндотрахеальная интубация: 15%;
4. неврологические заболевания: 12%;
5. причина неизвестна: 12%.

Центральные параличи (10%): надъядерные (кортикальные, кортикобульбарные) и бульбарные — при нарушении мозгового кровообращения, опухолях, черепно-мозговой травме, менингоэнцефалите, полиомиелите, ДЦП, рассеянном склерозе, после операций на мозге. Функциональные центральные — при нервно-психических расстройствах, чаще при истерии.

Односторонний паралич у детей

1. новообразования;
2. послеоперационные осложнения;
3. воспалительные процессы;
4. постинтубационная и наружная травма;
5. центральные и идиопатические параличи.

Закрытие артериального (боталлова) протока у новорождённых массой **менее 1000 г** часто даёт паралич левого возвратного нерва: стридор, осиплость, трудности кормления, аспирация.

Частота причин одностороннего паралича у детей

1. новообразования: 29%;
2. послеоперационные осложнения: 24%;
3. воспалительные процессы: 21%;
4. постинтубационная и наружная травма: 8%;
5. центральные: 5%, идиопатические: 13%.

Повреждение возвратного нерва при кардиохирургических вмешательствах: до 4%.

2.3 Классификация

1. по уровню поражения блуждающего нерва: центральные, периферические;
2. по этиологии: врождённые, приобретённые;
3. по распространённости: односторонние, двусторонние.

2.4 Клиническая картина

Страдают все функции гортани: разделительная (защитная), голосовая (охриплость), дыхательная (стеноз или гипервентиляция). Картина зависит прежде всего от положения парализованной складки.

Положение складки у взрослых

1. срединное;
2. парамедианное: 2 мм от срединной линии;
3. интермедианное: 4 мм;
4. латеральное: максимальное отведение на глубоком вдохе.

Проявления по положению голосовых складок

Поражение	Положение складки	Проявления
Одностороннее	медианное, парамедианное	дисфония небольшая; одышка только при нагрузке или избыточной массе; дисфагии нет
Одностороннее	интермедианное, латеральное	дисфония вплоть до афонии; одышки при нагрузке нет, но гипервентиляция; трудно откашляться, поперхивание; латеральное — при полном поражении блуждающего нерва
Двустороннее	латеральное	нарушение разделительной функции, афония, невозможность откашляться, гипервентиляция (головокружение при нагрузке и разговоре)
Двустороннее	интермедианное, парамедианное, медианное	на первый план — дыхательная недостаточность; голос может быть звучным, разделительная функция сохранена

Стадии паралитического стеноза гортани

Стадия стеноза	Голосовая щель у взрослых	Признаки
Компенсация	6–8 мм	одышки в покое нет, появляется при ходьбе
Субкомпенсация	3–4 мм	инспираторная одышка, при нагрузке — вспомогательные мышцы, втяжение межрёберий и ямок, стридор, бледность; давление нормальное или повышено
Декомпенсация	2–3 мм	частое поверхностное дыхание, резкий стридор, вынужденное положение сидя, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, нитевидный пульс, давление снижено
Асфиксия	1 мм	дыхание Чейна — Стокса или остановка, угнетение сердечной деятельности, потеря сознания, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца

Неплотное смыкание складок и ротация черпаловидного хряща ведут к аспирации (поперхиванию); одышка усиливается при голосовой нагрузке.

Последствия аспирации

1. ларингит;
2. трахеит;
3. аспирационная пневмония.

На состояние влияют

1. сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания;
2. эндокринные: гипотиреоз, гипопаратиреоз;
3. деформация шейного и грудного отделов позвоночника.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез: травма или операция на шее, органах средостения, шейном отделе позвоночника, головном мозге; инфекционные заболевания;
2. жалобы: дисфония, афония, дисфагия, одышка;
3. осмотр и пальпация гортани, оценка дыхания, признаки стеноза;
4. непрямая ларингоскопия, фиброларингоскопия, видеоларингоскопия, микроларингоскопия.

3.1 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы

1. одностороннее поражение: утомляемость голоса, придыхание, одышка при нагрузке, аспирация жидкостью; возможна дисфагия;
2. двустороннее: нарушение дыхания, инспираторный стридор при нагрузке, во сне, при разговоре.

Ларингоспазм может быть следствием синкинезии — неправильной реиннервации, когда на вдохе сокращаются суживающие мышцы; а также рефлюкса, гипокальциемии, аллергии, неврологических и психических расстройств.

Дыхательные нарушения при истерии: шумное стридорозное дыхание днём при посторонних, свободнее, когда пациент отвлекается, во сне — спокойное. Трахеотомия противопоказана, лечение — в психоневрологическом стационаре.

У детей

1. односторонний паралич: осиплость — 100% (в первый месяц может быть афония), затем аспирация при кормлении, стридор — около 36%;
2. двусторонний: инспираторный или двухфазный высокотональный стридор — 100%, усиливается при нагрузке, в 30% исчезает во сне; стеноз I–III степени.

3.2 Осмотр врача-оториноларинголога

Показания

1. все с подозрением на паралич гортани: осмотр оториноларинголога, пальпация шеи и регионарных лимфоузлов — воспаление, опухоль, травма.

Степени дыхательной недостаточности

1. I степень: одышка при умеренной нагрузке;
2. II: при малой нагрузке;
3. III: в покое.

Оценивают также рубцы на шее (сращение кожи с трахеей нарушает подвижность гортани) и неврологические признаки: асимметрию нёба, языка, фасцикуляции языка.

Признаки декомпенсации дыхания

1. общее состояние тяжёлое: слабость, апатия или крайнее беспокойство;
2. цианоз пальцев рук и лица;
3. одышка в покое и при небольшой физической нагрузке, шумное дыхание, озвученный вдох (инспираторная одышка), учащение дыхания;
4. участие вспомогательной мускулатуры в дыхании;
5. тахикардия, повышение артериального давления.

3.3 Общий анализ крови

Показания

1. подозрение на острое воспаление ЛОР-органов: развёрнутый общий (клинический) анализ крови.

3.4 Ларингоскопия

Показания

1. все с подозрением на парез или паралич: эндоскопическая ларингоскопия — микроларингоскопия, стробоскопия, видео- и фиброларингоскопия.

Непрямая ларингоскопия обязательна с **12 лет**; у дошкольников и младших школьников — видеофиброларингоскопия или фиброларингоскопия («золотой стандарт» у детей).

Диагностические признаки

1. неподвижность или резкое ограничение подвижности одной или обеих складок, черпаловидный хрящ ограниченно подвижен или неподвижен;
2. при фонации щель между складками: овальная, линейная, треугольная; здоровая складка может заходить за среднюю линию;
3. парализованная складка укорочена, атрофична: вогнутый серповидный край, истончение, выступающий голосовой отросток, складка ниже здоровой;
4. черпаловидный хрящ наклонён вперёд, ротирован медиально.

Дифференцируют

1. перихондрит (артрит) перстнечерпаловидного сустава: отёк, инфильтрация, гиперемия;
2. анкилоз: хрящ полностью неподвижен;
3. вывих: асимметрия суставов, воспаление, нетипичное положение хряща;
4. новообразования, ведущие к неподвижности складки.

Гипертрофия вестибулярных складок — компенсаторная, операции не требует.

У плачущего ребёнка складки сомкнуты, что имитирует двусторонний паралич: дождаться адекватного вдоха с разведением складок, которого при двустороннем параличе не будет.

3.5 Лучевые методы исследования

Показания: все пациенты с парезом или параличом гортани

1. КТ верхних дыхательных путей и шеи; при недоступности КТ — рентгенография гортани или шейного отдела позвоночника в двух проекциях;
2. КТ органов грудной полости: поиск объёмных образований;
3. УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи: поиск объёмных образований.

При подозрении на новообразование

1. КТ верхних дыхательных путей и шеи с контрастным усилением.

3.6 Консультации специалистов

Для поиска причины и выбора лечения показаны консультации эндокринолога и невролога; при подозрении на другие причины — пульмонолога, гастроэнтеролога, онколога.

4. Лечение

4.1 Медикаментозное лечение

Лечение основного заболевания в сочетании с антихолинэстеразными препаратами, стимулирующими нервно-мышечную передачу. Детям **до 18 лет** препараты противопоказаны.

Взрослые

1. #неостигмина метилсульфат в ранние сроки: внутрь 0,015 г 2 раза в день или 1 мл 0,05% раствора подкожно 1–2 раза в день, 2 недели;
2. #ипидакрин при одностороннем параличе: в/м 1 мл (15 мг) 1 раз в день 10 дней, затем 20 мг внутрь 3 раза в день (в КР «45 дней месяца»).

#Ипидакрин у взрослых с односторонним параличом — для восстановления подвижности парализованной складки.

Взрослые в ранние сроки: витамин B1 в комбинации с B6 и (или) B12. Учитывать противопоказания при онкологических заболеваниях; детям **до 18 лет** не назначают.

4.2 Логопедическая коррекция, физиотерапия и реабилитация

Показания

1. взрослые и дети с односторонним параличом: индивидуальная программа логопедической коррекции в самые ранние сроки, до окончания обследования и медикаментозного лечения;
2. все пациенты с параличом гортани, в том числе после операции: программа логопедической реабилитации.

Здоровая складка компенсаторно заходит за среднюю линию и смыкается с неподвижной. Три этапа; на каждом — дыхание, тонус и подвижность гортани, высота, сила и тембр голоса. Начинают при отсутствии боли в ране и острого воспаления.

Реабилитацию (логопедическая коррекция, физиотерапия) начинают с первого обращения, при параличе после операции или инсульта — **не позднее 72 часов** после установления диагноза, по возможности с участием мультидисциплинарной команды; амбулаторно или в дневном стационаре фониатрического центра.

Всем пациентам показана консультация физиотерапевта для улучшения трофики и нервно-мышечной передачи.

4.3 Хирургическое лечение у взрослых

Операции у взрослых

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
двусторонний паралич, декомпенсация, до 6 месяцев от поражения	временная хордопексия (латерофиксация складки)
двусторонний паралич, более 6 месяцев	двусторонняя хордопексия

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, дыхание через естественные пути невозможно, консервативное лечение неэффективно более 6 месяцев	микроэндоларингеальная резекция с эндоскопическими и лазерными технологиями, пластика гортани
двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика гортани и трахеи микрохирургически
односторонний паралич, более 6 месяцев	эндоларингеальное реконструктивное вмешательство на складках с имплантами — восстановление голоса

Пластика и резекция гортани не показаны при двустороннем параличе из-за неоперабельных опухолей щитовидной железы, лёгких, пищевода, метастазов в средостение: при декомпенсации — трахеотомия.

4.4 Хирургическое лечение у детей

Операции у детей

Ситуация	Операция
врождённый и приобретённый двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
дети старше 4 лет, двусторонний паралич, субкомпенсация, трахеостомы нет	хордаритеноидотомия эндоскопически
дети старше 4 лет, приобретённый двусторонний паралич, есть трахеостома	хордаритеноидотомия и контрлатеральная **через 6 месяцев** — для деканюляции
дети старше 4 лет, двусторонний паралич (в том числе приобретённый), есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старше 5 лет, врождённый двусторонний паралич без признаков восстановления, есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старшего возраста, двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания

1. срочная: острый и хронический паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации;
2. плановая: хирургическое лечение одно- или двустороннего паралича.

Выписка

1. после срочной госпитализации: восстановлено дыхание, нет дыхательной недостаточности;
2. после операции при двустороннем параличе: улучшено дыхание через естественные пути, стихли послеоперационные явления;
3. при одностороннем: улучшен голос.

5.2 Диспансерное наблюдение

Диспансерный осмотр оториноларинголога (фониатра) с ларингоскопией **раз в 3 или 6 месяцев** — в зависимости от дыхательной недостаточности.

5.3 Редкие синдромы с парезом гортани

Редкие синдромы

Синдром	Поражение и проявления
Тапиа	двойное ядро (IX, X), ядра XI, XII и пирамидные пути: парез глотки, мягкого нёба, гортани, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, языка, контралатеральный гемипарез; осложнение масочной вентиляции, интубации, бронхоскопии
Коле — Сикара	IX–XII нервы: охриплость, дисфагия, боль в глотке, нарушение вкуса задней трети языка; опухоли яремного отверстия, травма, аневризма, метастазы
Вернета	IX–XI: паралич нёба, гортани, глотки, грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц; огнестрельные ранения, переломы основания черепа, тромбоз яремной вены
Вилларе	IX–XII, симпатический нерв, волокна VII: дисфагия на твёрдую пищу, паралич нёба и гортани с одной стороны
Авеллиса	IX–XII: дисфагия, дисфония, дизартрия, гемигипестезия противоположных конечностей, опущение плеча

Односторонний паралич гортани может сопровождать боковой амиотрофический склероз, невралгическую амиотрофию (синдром Персонейджа — Тернера), множественную системную атрофию, травмы, опухоли, инсульт.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Парезы и параличи гортани»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 07.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	`305_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приёма #ипидакрина в таблетках записана как «45 дней месяца» — неясно, 45 дней или иной срок. Сверяйте с инструкцией препарата.